

预防医学学习指导与习题集名词解释汇总

第一章 绪论

1. 预防医学 (preventive medicine): 是医学的一门应用学科, 以个体和确定的群体为对象, 目的是促进和维护健康, 预防疾病、失能和早逝。其特点包括思维的整体性、服务的针对性和实践的主动性。
2. 公共卫生(public health): 以保障公众健康与健康公平为导向的公共事业, 由政府主导、社会协同, 运用多学科知识预防疾病、控制健康风险, 改善人群生理、心理及社会适应能力, 提高全民健康水平。
3. 健康(health): 不仅是无疾病或虚弱, 而是身体、心理和社会幸福的完好状态(WHO 定义)。健康是日常生活的资源, 包含身体健康、心理健康和社会健康三个维度。
4. 健康决定因素(determinants of health): 影响个体或群体健康状态的因素。分为四类: 社会经济环境(收入、教育、文化等), 物质环境(物理、化学、生物因素及建成环境), 个人因素(婴幼儿发育、卫生习惯、遗传等), 卫生服务(可及性、质量、公平性)。
5. 健康生态学模型(health ecological model): 解释健康影响因素的框架, 强调健康是核心层(个体生物学)、行为层、人际网络层、生活工作层、宏观政策层五层因素交互作用的结果。特点包括 多重性、交互性和多维性。
6. 三级预防 (preventions at three levels): 根据健康与疾病连续谱制定的预防策略。一级预防: 病因预防 (如健康教育、免疫接种); 二级预防: 临床前期 “三早” (早发现、早诊断、早治疗); 三级预防: 对已患病者防恶化、促康复。
7. 根本性预防 (primordial prevention): 一级预防的特殊形式, 在健康危险因素进入环境前采取的根本性措施 (如立法禁止有害化学物、公共场所禁烟), 从源头消除健康威胁。
8. 预防的高危策略(high-risk strategy of prevention): 针对疾病高风险个体进行干预(如高血压患者用药)。优点为针对性强、见效快; 局限性是对全人群疾病负担减少有限。
9. 预防的全人群策略(population strategy of prevention): 针对影响全人群的健康决定因素进行干预 (如控烟立法、减盐政策)。通过小幅降低人群整体风险水平(风险分布左移), 获得巨大健康收益(Rose 预防医学策略)。
10. “五星级医生” (“five-star” doctor) : WHO 提出的未来医生角色要求, 需具备五项能力: 卫生保健提供者、医疗决策者、健康教育者、社区卫生领导者、服务管理者。体现“防治结合”和以健康为中心的医学理念。

第二章 流行病学概论

1. 流行病学: 是研究人群中疾病与健康状况的分布及其影响因素, 并研究防治疾病及促进健康的策略和措施的科学。
2. 暴露: 指研究对象所具有的与结局有关的特征或状态(如年龄、性别、职业、遗传、行为、生活方式等)或曾接触与结局有关的某因素(如 X 线、重金属、环境因素等)。
3. 发病率: 表示一定期间内, 特定人群中某病新病例出现的频率。
4. 患病率: 指特定时间内总人口中曾患某病(新旧病例)之和所占的比例。
5. DALY: 伤残调整生命年, 指从发病到死亡所损失的全部健康生命年, 包括早死所致的生命损失年和伤残引起的健康生命损失年。
6. PYLL: 潜在减寿年数, 是某病某年龄组人群死亡者的期望寿命与实际死亡年龄之差的总和, 是指死亡所造成的寿命损失。
7. 暴发: 在一个局部地区或集体单位中, 在短时间内突然有很多同类的病例出现, 称为暴发。
8. 流行: 指某病在某地区的发病率显著超过历年(散发)的发病率水平。
9. 观察法: 不对研究对象施加任何干预或实验措施, 观察人群在自然状态下疾病、健康状况及有关因素的分布情况。
10. 混杂偏倚: 是指研究因素与疾病之间的关联程度受到其他因素的歪曲或干扰而产生的系统误差。导致混杂产生的因素称为混杂因素。混杂因素有以下特点: ①是疾病的危险因素; ②与研究因素有关; ③不是研究因素与研究疾病因果链上的中间病因。

11. 疾病自然史:疾病从发生、发展,直到结局的自然过程,我们称之为疾病自然史,如传染病的潜伏期、前驱期、发病期、恢复期等,慢性非传染病的亚临床期、症状早期、症状明显期、症状缓解期、恢复期等。

第三章 医学统计学概论

1. variation:变异,同质基础上各观察单位间某变量值的差异称为变异。
2. 总体: 是根据研究目的所确定的同质研究对象中所有观察单位某变量值的集合。
3. 小概率事件: 随机事件 A 的概率 $P \leq \alpha$, 则称随机事件 A 为小概率事件。通常取 $\alpha = 0.05$, 其统计学意义是小概率事件在一次随机试验中被认为不可能发生。
4. 中位数: 是一种位置指标, 用 M 表示, 是一组观察值按由小到大的顺序排列后位次居中的数值, 小于和大于中位数的观察值个数相等, 主要用于偏态分布资料以及频数分布的一端或两端无确切数值资料的中心位置的描述。
5. 几何均数: 可用于某些经对数变换后数据服从对称分布的偏态分布资料; 或某些观察值之间呈倍数或近似倍数变化关系的资料, 如抗体滴度、疫苗的平均效价等。
6. 变异系数: 常用于比较度量单位不同或均数相差悬殊的两组或多组资料的离散程度。
7. 医学参考值范围: 是指“正常人”的解剖、生理和生化等指标的波动范围。
8. 率: 是一类频率指标或强度指标。指在一定条件下, 某现象发生的例数与可能发生该现象的观察单位总数的比值。
9. 构成比: 是一类构成指标, 说明某事物 (或现象) 内部各组成部分所占的比例或分布, 常以百分数表示。
10. 相对比: 是 A 、 B 两个有关指标之比, 表征 A 与 B 间的比例关系。
11. 抽样误差: 因个体变异的存在, 抽样研究而导致的样本统计量间及样本统计量和总体参数间的差异, 称为抽样误差。
12. 检验水准: 亦称显著性水准, 符号为 α , 是判断拒绝或不拒绝 H_0 的水准, 也是允许犯 I 型错误的概率。
13. 检验效能: 亦称把握度, 即两总体确有差别时, 按 α 检验水准能识别该差别的能力。
14. 线性相关: 线性相关分析又称为简单相关分析, 主要用于分析服从双变量正态分布的两个变量间是否存在直线相关关系以及描述相关关系的强弱和方向。
15. 复相关系数: 决定系数的平方根称为复相关系数, 表示因变量 Y 与 m 个自变量间线性相关的程度。

第四章 环境卫生

1. 环境: 是指围绕人群的空间及其中能直接或间接影响人类生存和发展的各种因素的总体。
2. 大气圈: 主要指围绕地球周围的空气层, 可划分为对流层、平流层、中间层、热成层和逸散层 (外大气层)。
3. 环境因素: 是环境中的各种无机和有机的组成成分以及非物质因素。
4. 一次污染物: 是指从污染源直接排入环境未发生变化的污染物, 如二氧化硫等。
5. 二次污染物: 是指某些一次污染物进入环境后在物理、化学或生物学作用下, 或与其他物质发生反应而形成与初始污染物的理化性质和毒性完全不同的新的污染物。
6. 室内空气污染: 室内引入能释放污染物的污染源或室内环境通风不佳导致室内空气中污染物在浓度或种类上不断增加, 当污染物在有限的空间达到一定浓度后, 对人体身心健康产生直接或间接的、近期或远期的, 或者潜在的有害影响, 称为室内空气污染。
7. 水体富营养化: 含磷、氮等污水污染造成水体中藻类大量繁殖, 使水中有机物增加、溶解氧下降, 导致水质恶化的现象, 称为水体富营养化。
8. 健康效应谱: 不同级别的效应在人群中的分布称为健康效应谱。
9. 生物标志物: 是生物体内发生的与发病机制有关联的关键事件的指示物, 是机体由于接触各种环境因子所引起机体器官、细胞、亚细胞的生化、生理、免疫和遗传等任何可测定的改变。
10. 环境污染性疾病: 凡能污染环境, 使环境质量恶化, 而直接或间接使人患病的环境污染因素, 统称为环境污染性致病因素, 由此在暴露人群中引发的疾病称为环境污染性疾病。
11. 人群易感性: 在同一环境暴露条件下, 人体对环境异常变化的反应强度及性质不同, 对某些污染物特别敏感的人群称易感人群或高危人群, 这种现象称为人群易感性。

12. environmental pollution:环境污染,由于各种自然或人为的原因,进入环境的污染物数量超过环境的自净能力,造成环境质量下降和恶化,直接或间接影响人体和其他生物的健康,称为环境污染。
13. 污染物的迁移: 污染物在环境中所发生的空间位置相对移动及其所引起的富集、分散和消失的过程称为污染物的迁移。
14. transformation: 转化, 是指污染物在环境中主要经过化学或生物的作用改变其存在形态或转变为不同物质的过程。
15. 蓄积: 污染物的吸收速度超过代谢与排泄的速度, 以相对较高的浓度富集于某些组织或器官的现象称为蓄积。
16. 生物地球化学性疾病:由于地壳表面化学元素分布的不均匀性,某些地区的水和/或土壤中某些元素过多或过少,当地居民通过饮水、食物等途径摄入这些元素过多或过少,而引起某些特异性疾病,称为生物地球化学性疾病。
17. 碘缺乏病:是指从胚胎发育至成人期由碘摄入量不足而引起的一系列病症。不同程度碘缺乏在人类不同发育期可引起不同的损伤,地方性甲状腺肿和地方性克汀病是碘缺乏病最明显的表现形式。
18. 地方性甲状腺肿: 是一种主要由地区性环境缺碘引起的地方病, 是碘缺乏病的主要表现形式之一, 其主要症状是甲状腺肿大。
19. 地方性克汀病: 是在碘缺乏地区出现的比较严重的碘缺乏病。患者出生后即有不同程度的智力低下, 体格矮小, 听力障碍, 神经运动障碍和甲状腺功能减退, 伴有甲状腺肿。可概括为呆、小、聋、哑、瘫。
20. 地方性氟中毒: 是由于一定地区的环境中氟元素过多, 而致生活在该环境中的居民经饮水、食物和空气等途径长期摄入过量氟所引起的以氟骨症和氟斑牙为主要特征的一种慢性全身性疾病, 又称地方性氟病。
21. 氟斑牙:又称氟牙症或斑釉,是因牙釉质在发育期摄入了过多氟导致的牙体组织疾病。多发生于恒牙, 是氟中毒的早期表现。主要表现为釉面光泽度改变,釉面着色,釉面缺损。
22. 地方性砷中毒: 是由于长期自饮用水、室内煤烟、食物等环境介质中摄入过量的砷而引起的一种生物地球化学性疾病。临床上以末梢神经炎、皮肤色素代谢异常、掌跖部皮肤角化、肢端缺血坏疽、皮肤癌变为主要表现, 是一种伴有多系统、多脏器受损的慢性全身性疾病。
23. 乌脚病: 此种病多发生于下肢远端脚趾部位, 早期以间歇性跛行为主要表现, 久之脚趾皮肤发黑、坏死(黑脚病), 患者主诉脚背、脚趾发凉, 颜色苍白, 足背动脉搏动减弱或消失。失活、坏死、发黑的皮肤可部分自行脱落, 或需手术切除。
24. 危险度评估: 主要通过毒理学研究结合人群流行病学调查资料, 系统评价有害环境因素暴露对人类和生态的潜在损害作用, 并对损害作用的相关证据强度或风险评估的不确定性进行评价。
25. 基准剂量:依据动物实验剂量-反应关系的结果,用一定的统计学模型求得的受试物引起一定比例(定量资料为 10%, 定性资料为 5%)动物出现阳性反应剂量的 95% CI 下限值。
26. 危害识别: 指识别环境因素在机体、系统或(亚)人群是否引起有害效应及有害效应的种类和性质, 是危险度评估的首要步骤, 属于定性评价。

第五章 职业卫生与职业医学

1. 职业性有害因素: 是指在职业活动中产生和/或存在的, 并可能对职业人群的健康、人身安全及作业能力造成有害影响的因素或条件。
2. 生产性毒物: 是指生产工艺过程中使用或产生的, 存在于作业环境中的毒物。
3. 职业中毒:由生产性毒物引起的中毒称为职业中毒。
4. 刺激性气体: 是指对眼、呼吸道黏膜及皮肤具有刺激作用的一类气态物质, 包括常态下的气体以及通过蒸发、升华或挥发而形成蒸气或气体的液体和固体物质, 多具腐蚀性。
5. 窒息性气体: 是指被吸入后引起氧的供给、摄取、运输和利用发生障碍, 使全身组织细胞得不到或不能利用氧, 而导致组织细胞缺氧窒息的一类有害气体的总称。
6. 生产性粉尘: 是指生产过程中产生的并能较长时间悬浮于生产环境中的固体颗粒物, 是污染作业环境、损害劳动者健康的重要职业性有害因素。
7. 可吸入粉尘:是指空气动力学直径小于 $15\ \mu\text{m}$ 的可进入呼吸道的颗粒物。
8. 呼吸性粉尘: 是指空气动力学直径小于 $5\ \mu\text{m}$ 的可随呼吸到达呼吸道深部和肺泡区的颗粒物。
9. 尘肺病: 长期吸入生产性粉尘并有粉尘在肺内阻留, 从而引起的以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病。

10. 高温作业: 是指有高气温, 或有强烈的热辐射, 或伴有高气湿相结合的异常气象条件、湿球黑球温度指数超过规定限值的作业。
11. 中暑: 是指高温环境下由于热平衡和/或水盐代谢紊乱等而引起的一种以中枢神经系统和/或心血管系统功能障碍为主的急性热致疾病。
12. 生产性噪声: 是指生产过程中产生的噪声。
13. 局部振动病: 是指长期从事手传振动作业引起的以手部末梢循环障碍和/或手臂神经功能障碍为主的疾病。
14. 非电离辐射: 是指量子能量小于 12 电子伏特(eV), 不能引起生物体电离的电磁辐射。
15. 职业紧张: 是指在某种职业条件下, 工作需求超过个体应对能力而产生的生理和心理压力。
16. 工效学: 是以人、机器、环境三者为中心, 研究人、机器设备、环境三者之间的相互关系, 目的是实现人在生产劳动及其他活动中的健康、安全、舒适, 同时提高工作效率。
17. 职业性损害: 是指职业性有害因素在一定条件下对劳动者健康和劳动能力产生不同程度的损害。
18. 职业病: 广义上的职业病是指职业性有害因素作用于人体的强度与时间超过一定限度时, 人体不能代偿其所造成的功能性或器质性病理改变, 从而出现相应的临床症状和体征, 影响劳动能力。
19. 工作有关疾病: 是一类与多因素相关的疾病。在职业活动中, 由于职业性有害因素等多种因素的作用, 劳动者罹患某种疾病或潜在疾病显露或原有疾病加重, 又称职业性多发病。
20. 职业性外伤: 又称工伤, 属于工作中的意外事故引起的伤害, 主要指在工作时间和工作场所内, 因工作原因由意外事故造成的职业从事者的健康损害。
21. 个人防护用品: 是指个人用于最大限度地减少或避免由于暴露于职业性有害因素所导致的事故伤害和职业危害而随身穿(佩)戴的用品。
22. 职业卫生服务: 是一种在工作场所或其附近提供的全面保护劳动者健康的服务, 内容是预防性的, 目的是使工作符合劳动者的健康要求。
23. 职业健康监护: 是以预防为目的, 根据劳动者的职业接触史, 通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集, 连续性地监测劳动者的健康状况, 分析劳动者健康变化与所接触的职业病危险因素的关系, 并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人, 以便及时采取干预措施, 保护劳动者健康。
24. 工作场所健康促进: 也称为职业健康促进(occupational health promotion), 是指采取综合干预措施, 以改善工作条件, 改变劳动者不健康生活方式和行为, 控制健康危险因素, 预防职业病, 减少工作有关疾病的发生, 促进和提高劳动者健康和生命质量为目的的活动。
25. 职业病的三级预防: 第一级预防又称病因预防, 是从根本上消除或控制职业性有害因素对劳动者的作用和损害; 第二级预防是早期检测和诊断人体受到职业性有害因素所致的健康损害; 第三级预防是指在患病以后, 给予积极治疗和促进康复的措施。

第六章 食物与健康

1. nutrition: 营养, 是机体从外界环境中摄取食物, 经过体内消化、吸收和代谢, 以满足机体生理功能、生长发育、组织更新和身体活动必需的生物学过程。
2. dietary reference intakes (DRIs): 膳食营养素参考摄入量, 是为了保证人体合理摄入营养素, 避免缺乏和过量, 以及降低慢性病风险, 在推荐膳食营养素供给量的基础上发展起来的每日平均膳食营养素摄入量的一组参考值。包括平均需要量、推荐摄入量、适宜摄入量、可耐受最高摄入量、宏量营养素可接受范围、降低膳食相关非传染性疾病风险的建议摄入量和特定建议值。
3. recommended nutrient intake (RNI): 推荐摄入量, 是可满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中 97%~98% 个体需要量的摄入水平, 相当于传统的每日膳食中营养素供给量。
4. acceptable macronutrient distribution ranges (AMDR): 宏量营养素可接受范围, 是脂肪、蛋白质和碳水化合物理想的摄入量范围, 该范围可以提供这些必需营养素的需要, 并且有利于降低慢性病的发生危险, 常用占能量摄入量的百分比表示。其显著的特点之一是具有上限和下限。
5. essential amino acid (EAA): 必需氨基酸, 是在体内不能合成或合成速度不能满足机体需要, 必须从食物中获取的氨基酸。
6. positive nitrogen balance: 正氮平衡, 是婴幼儿、青少年、孕妇和乳母为了满足组织细胞增长和泌乳的需要, 摄入氮量大于排出氮量, 即为正氮平衡。
7. essential fatty acid (EFA): 必需脂肪酸, 是人体必需的、自身不能合成的、必须由食物供给的多不饱和脂肪酸。

8. dietary fiber: 膳食纤维, 是不能被人体利用的多糖, 即不能被人体胃肠道中消化酶所消化的且不被人体吸收利用的多糖, 主要来自植物细胞壁的复合碳水化合物, 包括纤维素、半纤维素、果胶及木质素等。
9. thermic effect of food: 食物的热效应, 是人体由于摄取食物所引起的额外能量消耗, 是食物的消化、运输、代谢和贮存活动中所额外消耗的能量。
10. essential microelements: 必需微量元素, 元素在组织中浓度不超过 $250 \mu\text{g/g}$, 若该元素的摄入量减少到低于某一限值, 总会导致一种重要生理功能的损伤, 或该元素是机体内生物活性物质有机结构的组成成分。
11. foodborne diseases: 食源性疾病, 是指食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性等疾病, 包括食物中毒。
12. 口腔生殖系综合征: 是一组由于核黄素(维生素 B2) 缺乏而出现的口角炎、眼睑缘炎、阴囊(阴唇) 皮炎、鼻翼两侧脂溢性皮炎等口腔和阴部炎症综合征, 故称此现象为“口腔生殖系综合征”。
13. 平衡膳食: 即为合理膳食, 是指提供给机体种类齐全、数量充足、比例合适的能量和各种营养素, 并与机体的需要保持平衡, 进而达到合理营养、促进健康、预防疾病的膳食。
14. 营养不良: 是由于一种或一种以上营养素的缺乏或过剩所造成的机体健康异常或疾病状态。
15. 营养风险筛查: 是发现患者是否存在营养问题和是否需要进一步进行全面营养评估的过程。
16. 营养评估: 是在大量临床资料中收集相关资料, 如一般状况、饮食情况、身体测量指标和生化指标, 按营养状态对患者进行分类, 分为营养良好或营养不良, 并评估患者营养不良的程度, 从而进行相应的营养治疗。
17. 治疗膳食: 是根据不同的病理与生理状况, 调整患者膳食的营养成分和性状, 治疗或辅助治疗疾病、促进患者康复的膳食。
18. 肠内营养: 是具有胃肠道消化吸收功能的患者, 因机体病理、生理改变或一些治疗的特殊要求, 需利用口服或管饲等方式给予要素膳制剂, 经胃肠道消化吸收, 提供能量和营养素, 以满足机体代谢需要的营养支持疗法。
19. 肠外营养: 是通过肠道以外的通路即静脉途径输注能量和各种营养素, 以达到纠正或预防营养不良、维持营养平衡目的的营养补充方式。
20. 食物中毒: 指摄入含有生物性、化学性有毒有害物质的食品或把有毒有害物质当作食品摄入后所出现的非传染性(不同于传染病) 的急性、亚急性疾病。
21. 细菌性食物中毒: 是指摄入被细菌和/或其毒素污染的食物而引起的急性或亚急性疾病。

第七章 健康行为干预

1. 健康教育: 是有计划地应用循证的教学原理与技术, 为学习者提供获取科学的健康知识、树立健康观念、掌握健康技能的机会, 帮助他们作出有益健康的决定和有效且成功地执行有益健康的生活行为方式的过程。
2. 增权: 是指人们增强对决定他们生命事件掌控力的过程, 即有能力对决定自身健康的问题作出明智的选择。
3. 健康素养: 是在进行与医疗服务、疾病预防和健康促进有关的日常活动时, 获取、理解、评价和应用健康信息来做出健康相关决定以维持或提高生活质量的知识、动机和能力。
4. 健康促进: 是促使人们维护和提高他们自身健康的过程。健康促进是一个综合的社会政治过程, 它不仅包含了加强个人素质和能力的行动, 还包括改变物质、社会环境以及经济条件, 从而削弱它们对大众及个人健康的不良影响。
5. 健康共治: 是指各级政府及相关部门以“整个政府和全社会的路径”引导社会组织、企业和公众为了健康和福祉共同采取的行动。
6. 自我效能: 是一种相信自己能在特定环境中恰当而有效地实施某种行为的信念。
7. 健康咨询: 是临床场所尤其是基层卫生保健机构帮助个体及家庭改变不良行为最常用的一种健康教育方式。

第八章 全生命周期保健

1. 新生儿疾病筛查: 是指在新生儿期对严重危害新生儿健康的先天性、遗传性疾病施行专项检查, 提供早期诊断和治疗的母婴保健技术, 是提高出生人口素质、减少出生缺陷的预防措施之一。

2. 身高别体重: 是指一定身高相应的体重增长范围, 用来表示相对于目前身高的体重信息, 可间接反映身体的密度与充实度。
3. 婚前医学检查: 是指对准备结婚的男女双方可能患影响结婚和生育的疾病进行的医学检查。
4. 生育调节: 是通过人工的方法或根据人体体内的激素变化所引起的一系列生理变化征象来调节促进人的生育功能, 达到避孕或计划受孕的目的。
5. 劳动力人口: 是指劳动适龄人口中具有劳动能力的那部分人口。
6. premarital health care: 婚前保健, 是为准备结婚的男女双方在结婚登记前所进行的婚前医学检查、婚前卫生指导和婚前卫生咨询。

第九章 慢性非传染性疾病预防及控制

1. 慢性非传染性疾病: 不是特指某种疾病, 而是对一组起病时间长, 缺乏明确病因证据, 一旦发病即病情迁延不愈的非传染性疾病的概括性总称。
2. 生命全程: 也称全生命周期, 是一个人从出生到死亡、从受精卵开始到生命结束的完整过程。
3. 关键期模型: 是指在特定时期的暴露对器官、组织和身体系统的结构和功能的持久的、终身的影响, 这种模式也称为“生物学规划”或“潜伏期模型”。
4. 后期效应修正的临界模型: 是指后期生活因素可能会改变关键时期暴露对后来疾病风险的影响, 是关键期模型的延伸。
5. 风险累积模型: 是指多种效应在生命全程中的累积, 从基因遗传到子宫内发育、童年、少年、青年、中年和老年的健康和社会暴露, 着重于暴露的总量和/或次序。
6. 路径模型/风险链模型: 是指一系列相互联系的生物、心理和社会途径暴露的整合, 而暴露时间可能以多种不同方式影响疾病风险。
7. 慢性病健康管理: 是指以生物-心理-社会医学模式为指导, 组织慢性病专业医生及护理人员, 通过为健康人群、慢性病风险人群、慢性病患者提供全面、连续、主动的管理, 以达到促进健康、延缓慢性病进程、减少并发症、降低伤残率、延长寿命、提高生活质量, 同时降低医药费用为目的的一种科学健康管理模式。
8. 慢性病自我管理: 是指通过系列健康教育课程教给患者自我管理所需知识、技能以及和医生交流的技巧, 帮助慢性病患者在得到医生更有效的支持下, 能主要依靠自己解决慢性病给日常生活带来的各种躯体和情绪方面的问题。

第十章 传染病的预防及控制

1. 潜隐期(latent period): 指从个体感染病原体到具备传染性所需的时间。潜隐期可能短于或等于潜伏期; 若短于潜伏期, 则患者在出现症状前已能传播病原体。
2. 垂直传播(vertical transmission): 病原体从母体传给子代的过程, 包括经胎盘传播(如乙肝病毒)、上行性传播(如单纯疱疹病毒)、分娩时传播(如淋球菌)。
3. 疫源地(epidemic focus): 传染源及其排出的病原体所能波及的范围。疫源地消灭需满足: 传染源移走/不再排病原体、环境病原体被清除、所有易感接触者度过最长潜伏期无新病例。
4. 基本再生数(basic reproduction number, R_0): 指在没有任何干预措施且所有人都易感的情况下, 平均每位感染者在其传染期内能够引起的二代感染者的数量。表示一个感染者在完全易感人群中、没有任何干预措施情况下平均能够传染的新感染者数量。
5. 有效再生数(effective reproduction number, R_{eff}): 在实施干预措施(如隔离、接种疫苗)后, 平均每位感染者实际引起的二代感染者数量。反映现实条件下的传播能力。
6. 预防接种(immunization): 将疫苗或抗体接种到机体, 使机体获得对传染病的特异性免疫力, 从而保护易感人群, 预防传染病的发生。
7. 病例定义(case definition): 是在暴发调查中用来判断个体是否应当被归类为病例的一套标准, 与日常临床诊断标准可以不完全一致。暴发调查中的病例定义通常包括流行病学标准(时间、地点和人群范围)和临床诊断标准(病例的临床症状体征、临床一般检查和实验室特异性检测结果)。
8. 同一健康(one health): 整合人类健康、动物健康和环境健康的协作理念, 旨在共同应对传染病等全球卫生问题。
9. 主动免疫(active immunity): 指将疫苗接种到机体, 使之产生特异性免疫。

10. 暴发调查(outbreak investigation): 对局部地区短期内集中出现同种传染病病例的调查。步骤包括核实诊断、制定病例定义、描述三间分布、形成假设、采取控制措施。

第十一章 筛检

1. 筛检试验: 筛检所用的各种手段和方法, 它可以是问卷调查、体格检查、内镜与 X 线等物理学检查, 也可以是细胞学或分子标志物等实验室检查。
2. 整群筛检: 是指在疾病患(发)病率很高的情况下, 对一定范围内人群的全体对象进行普遍筛检, 即普查。
3. 选择性筛检: 是指在某范围内根据流行病学特征选择高危人群进行筛检, 最大限度地发现那些无临床症状的病例, 以取得最大的筛检效益。
4. 主动筛检: 采取“主动出击”, 通过组织的宣传介绍, 动员群众到筛检服务地点进行检查。
5. 机会性筛检: 属于一种被动性筛检, 是将日常性的医疗服务与目标疾病的患者筛检结合起来, 在患者就医过程中, 对具有高危因素的人群进行的筛检。

第十二章 疾病转归与预后

1. prognosis: 预后, 是指在疾病发生之后, 对该病未来的发展过程和转归 (治愈、复发、恶化、并发症发生、伤残、死亡等) 的事先估计。
2. 预后因素: 是指影响疾病结局的一切因素, 强调患者具有某些因素, 其病程发展中出现某种结局的概率就可能发生改变。
3. 生存率: 是指在接受某种治疗的患者或者患某病的人群中, 经过 n 年随访后, 尚存活的病例数占的比例。
4. 病死率: 是指在一定时期内, 某病的全部患者中因该病死亡者所占的比例。
5. 缓解率: 是指某种疾病患者经过某种治疗后, 病情得到缓解的人数占治疗总人数的比例。
6. 复发率: 是指某病患者中, 在缓解或痊愈后的一段时期内又复发者所占的比例。
7. 转移率: 是指发生肿瘤转移的患者占观察肿瘤患者的比例, 用于肿瘤的预后评价。
8. overall survival: 总生存期, 是指从病程某时点(诊断、治疗、随机化)开始至因任何原因引起死亡的时间。
9. disease-free survival: 无病生存期, 是指从根治性治疗开始至疾病复发、转移或由于任何原因引起死亡的时间。
10. 失效事件: 又称为终点事件、死亡事件, 是指反映随访观察效果特征的事件。
11. 截尾数据: 又称不完全数据、删失数据, 指在随访过程中, 由于某种原因未能观察到患者的明确结局, 所以无法明确患者确切的生存时间, 即患者提供的生存时间信息是不完全的, 故称为截尾数据。
12. 生存时间: 任何两个有联系的事件之间的时间间隔, 常用字母 t 表示, 在生存分析中称为时间变量。

第十三章 医院感染的监测与控制

1. nosocomial infection: 医院感染, 指在医院内获得的感染, 包括在住院期间发生的感染和在医院内获得离院后发生的感染。
2. 医院感染监测: 是指长期、系统、连续地收集、分析医院感染在特定人群中的发生、分布及其影响因素, 对监测资料定期进行整理分析, 并将监测结果报送和反馈给有关部门和科室, 为医院感染的预防、控制和管理提供科学依据。
3. 医院感染数据: 是指患者在住院期间与医院感染有关的医疗数据。包括医院感染发生率、漏报率、感染部位分布、易感人群监测、高危因素监测、抗生素耐药情况、外环境及消毒物品监测等。
4. 风险评估: 是在识别潜在危害后, 对其危害发生的概率和严重程度的估计并评估各种风险降低措施的过程。主要有定性评估、半定量评估、定量评估。
5. contact transmission: 接触传播, 指病原体通过直接接触感染源, 或者通过被污染的物体表面传播到健康人体内。如肠道传染病、经血传播疾病、多重耐药菌感染、皮肤感染等。

第十四章 突发公共卫生事件

1. 突发公共卫生事件: 指突然发生, 造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件(依据《突发公共卫生事件应急条例》)。
2. 重大传染病疫情: 指传染病的暴发(在一个局部地区短期内突然发生多例同一种传染病)和流行(一个地区某种传染病发病率显著超过该病历年的一般发病率水平), 包括鼠疫、肺炭疽和霍乱的暴发, 动物间鼠疫、布鲁氏菌病和炭疽等流行, 乙、丙类传染病暴发或多例死亡, 罕见或已消灭的传染病, 新传染病的暴发等。
3. 群体性不明原因疾病: 在短时间内, 某个相对集中的区域内同时或相继出现具有共同临床表现的患者, 且病例不断增加、范围扩大, 暂时无法明确诊断的疾病(如学校、社区内突发聚集性病例)。
4. 特别重大突发公共卫生事件(I级): 由国务院认定的最高级别事件, 需满足严苛条件(如肺鼠疫在大城市扩散、新传染病传入并有扩散趋势、涉及多省份的群体性不明原因疾病等)。
5. 突发公共卫生事件风险评估: 对事件发生的可能性及后果严重性进行科学研判的系统过程, 包括风险识别、风险分析和风险评价三个环节, 需整合多源数据并考虑不确定性。
6. 专家会商法: 突发公共卫生事件风险评估的常用定性方法, 通过多领域专家集体讨论, 综合分析事件发展趋势、危害程度及防控策略。
7. 检伤分类: 医务人员按规范对伤病员进行紧急分级(红色标: 危重优先; 黄色标: 重症次优先; 绿色标: 轻症; 黑色标: 死亡), 标记于明显部位以指导救治顺序。
8. “一案三制”: 卫生应急管理体系的核心框架, 包括应急预案(龙头)、应急管理体制(组织框架)、应急机制(运行制度)和应急法制(法律保障)。
9. 四集中原则: 伤病员救治的核心策略, 指集中资源、集中专家、集中伤病员、集中救治, 优先收治于综合实力强的医疗机构。
10. 风险沟通: 将风险评估结果向决策者、媒体和公众有效传递的过程, 旨在指导防护措施、消除恐慌并协调应对行动。

第十五章 预防保健策略

1. 卫生系统: 指所有致力于进行卫生活动的组织、机构和资源。
2. 健康公平性: 指要求所有社会成员均有公平的机会获得尽可能高的健康水平, 或者定义为创造相等的获得健康的机会, 并将不同社会人群健康的差别降到最低水平。
3. 反应性: 指卫生系统能够满足人们合理期望的程度。
4. 卫生组织: 指以促进、恢复和维护人群健康为基本目的的机构或团体。
5. 卫生行政组织: 指那些通过制定和执行卫生政策、法规来引导和调控卫生事业的发展, 将组织和管理卫生相关事务作为主要职能的政府组织。
6. 卫生服务组织: 是以保障居民健康为主要目标, 直接或间接向居民提供预防服务、医疗服务、康复服务、健康教育和健康促进等服务的组织。
7. 医疗保险: 是将多种渠道筹集的经费(保险费)集中起来形成基金(医疗保险基金), 用于补偿个人(被保险人)因病或其他损伤所造成的经济损失的一种制度。
8. 补充医疗保险: 是由单位、企业或特定人群, 根据自己的经济承担能力, 在基本医疗保险制度基础上自愿参加的各种辅助性的医疗保险, 其主要解决参保人员基本医疗保险支付范围以外的医疗保险费用, 是对基本医疗保险制度的补充。
9. 长期护理保险: 是指对被保险人因为年老、严重或慢性疾病、意外伤残等导致身体上的某些功能全部或部分丧失, 生活无法自理, 需要入住长期护理机构, 譬如安养院等, 接受长期的康复和支持护理或在家中接受他人护理时支付的各种费用给予补偿的一种健康保险。
10. 按病种付费: 按疾病诊断相关分组(DRG)付费, 是根据年龄、疾病诊断、合并症、并发症、治疗方式、病症严重程度及转归和资源消耗等因素, 将患者分入若干诊断组进行管理的体系。近年我国推行自己原创的按病种分值付费(DIP), 是利用大数据优势所建立的完整管理体系, 发掘“疾病诊断+治疗方式”的共性特征对病案数据进行客观分类, 在一定区域范围的全样本病例数据中形成每一个疾病与治疗方式组合的标化定位, 客观反映疾病严重程度、治疗复杂状态、资源消耗水平与临床行为规范。DRG 和 DIP 均属于按病种付费。
11. 总额预付: 是由政府或医疗保险机构与医疗机构协商, 根据医院的实际情况, 确定医疗保险支付每个医疗机构医疗费用年度总预算额。

12. global health: 全球健康, 是以提高全球范围内的健康水平、实现全球健康公平为宗旨, 重点关注超越国界和地域的健康问题、健康决定因素和解决方案, 提倡不同学科间的通力合作。全球健康是一个实践性极强的领域, 其根本目的在于切实解决全球范围内的卫生与健康问题。
13. global public health security: 全球公共健康安全, 是指对危及不同区域以及跨国范围公众群体健康的紧急公共卫生事件, 尽可能减少危害而采取的预防性和反应性行动。
14. 健康中国: 是旨在全面提高全民健康水平的国家战略。以提高人民健康水平为核心, 以体制机制改革创新为动力, 从广泛的健康影响因素入手, 把人民健康放在优先发展的战略地位, 把健康融入所有政策, 全方位、全周期保障人民健康, 大幅提高健康水平, 显著促进健康公平, 促进全民健康建设。